BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM AN TOÀN

Biên soạn theo đề cương Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023
Bản trình thẩm định chuyên môn
Cập nhật ngày 13/10/2026

Mã tài liệu theo bản nguồn: ĐH.QT.15.ĐD
Phiên bản: ..... Ngày áp dụng: .....
Số quyết định ban hành của bệnh viện: .....

Vai trò	Họ và tên / Chức danh	Chữ ký / Ngày
Người biên soạn	.....	
Người kiểm tra	.....	
Người phê duyệt	.....	

Thông tin ban hành và chữ ký chỉ được hoàn tất khi bệnh viện thẩm định, phê duyệt; không dùng bản trình thẩm định như văn bản đã ban hành.

Hội đồng thẩm định và ban biên soạn

Chủ tịch hội đồng: .....
Thành viên: .....
Ban biên soạn: .....
Đơn vị quản lý: Phòng Điều dưỡng; phối hợp Khoa Dược, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và các đơn vị liên quan.

Lời nói đầu

Tài liệu thống nhất những yêu cầu an toàn khi tiêm tại Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân. Phần quy trình chính được sắp xếp theo 7 mục của Quyết định 3023/QĐ-BYT; các phụ lục thực hành và bảng kiểm của tài liệu nguồn năm 2025 được giữ để hỗ trợ đào tạo, giám sát.

Quyết định 3023/QĐ-BYT quy định đề cương và thể thức tài liệu. Các chỉ định thuốc, liều, nồng độ, tốc độ, thử nghiệm dị ứng, truyền máu và xử trí cấp cứu phải theo hướng dẫn chuyên môn, chế phẩm và quy trình bệnh viện được phê duyệt.

Mục lục

1. ĐẠI CƯƠNG

2. CHỈ ĐỊNH

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

4. THẬN TRỌNG

5. CHUẨN BỊ

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC DANH MỤC CHUẨN BỊ

10 phụ lục thực hành: tiêu chuẩn tiêm an toàn; rửa tay; sát khuẩn tay nhanh; phiếu quan sát; thử trong da và lấy da; tiêm dưới da; tiêm tĩnh mạch; truyền dịch; lấy máu tĩnh mạch; truyền máu.

Danh mục chữ viết tắt

NB: người bệnh; ĐD: điều dưỡng; HS: hộ sinh; BS: bác sĩ; TAT: tiêm an toàn; QTKT: quy trình kỹ thuật; KSNK: kiểm soát nhiễm khuẩn; VSN: vật sắc nhọn; TM: tĩnh mạch; ADR: phản ứng có hại của thuốc; SpO_2: độ bão hòa oxy ngoại vi; mL: mililít.

1. ĐẠI CƯƠNG

Tiêm là đưa thuốc hoặc chế phẩm vào cơ thể qua kim/bơm tiêm theo đường được chỉ định, như trong da, dưới da, trong cơ hoặc tĩnh mạch. Tiêm an toàn là thực hiện mũi tiêm bảo đảm an toàn cho người nhận, người thực hiện và cộng đồng.

Nguyên lý: đúng chỉ định, đúng người bệnh và thuốc; giữ vô khuẩn trong chuẩn bị và thực hiện; kiểm soát vật sắc nhọn; theo dõi đáp ứng và xử trí kịp thời bất thường. Mục đích là thống nhất thực hành, phòng ngừa sai sót, tai biến, nhiễm khuẩn và phơi nhiễm nghề nghiệp.

Phạm vi: quy trình chung cho tiêm trong da, dưới da, tiêm bắp, tiêm/truyền TM tại các khoa được phép thực hiện. Phụ lục lấy máu và truyền máu là tài liệu hỗ trợ; thử nghiệm dị ứng, lấy mẫu và truyền máu phải dùng quy trình chuyên biệt đã phê duyệt.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có y lệnh hợp lệ về thuốc/chế phẩm và đường dùng, phù hợp dạng bào chế, mục tiêu điều trị và tình trạng lâm sàng.

- Nhân viên được đào tạo, có năng lực và được phân công trong phạm vi hành nghề thực hiện kỹ thuật tương ứng.

- Thử nghiệm da, tiêm vắc xin, thuốc nguy cơ cao và truyền chế phẩm đặc thù thực hiện khi có chỉ định và hướng dẫn riêng phù hợp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Các biện pháp an toàn luôn phải được thực hiện. Chống chỉ định của mũi tiêm được xác định theo thuốc, đường dùng và vị trí cụ thể, không phải chống chỉ định của việc bảo đảm an toàn.

- Không thực hiện thuốc/đường dùng khi có chống chỉ định theo chế phẩm hoặc phác đồ; không tiêm chế phẩm không được phép dùng đường đó.

- Không chọc vào vùng viêm, nhiễm khuẩn hoặc tổn thương không phù hợp; đánh giá và chọn vị trí khác theo kỹ thuật.

- Tạm chưa thực hiện khi y lệnh chưa rõ, nhận diện NB chưa chính xác, thuốc nghi sai/hỏng/hết hạn, thiếu phương tiện hoặc không bảo đảm vô khuẩn; báo bác sĩ và giải quyết trước thực hiện. Tình huống cấp cứu thực hiện theo phác đồ và thẩm quyền.

4. THẬN TRỌNG

- Kiểm tra dị ứng đã ghi nhận và thay đổi mới; kết quả thử nghiệm da âm tính không loại trừ phản vệ. Không thử phản ứng thường quy cho mọi thuốc.

- Trẻ nhỏ, người cao tuổi, rối loạn đông máu/dùng thuốc chống đông, rối loạn ý thức, khó hợp tác hoặc có bệnh kèm: đánh giá nguy cơ, chọn vị trí/cỡ kim/tư thế và theo dõi phù hợp.

- Thuốc kích ứng hoặc gây tổn thương mô, ảnh hưởng huyết động và thuốc nguy cơ cao cần đường truyền, nồng độ, tương hợp, tốc độ và kiểm tra theo quy trình cụ thể.

- Không hút kiểm tra hoặc áp dụng một tốc độ/góc kim/thể tích chung cho tất cả thuốc. Tiêm vắc xin thực hiện theo hướng dẫn vắc xin.

- Dự phòng chuyển động đột ngột; không tự tiêm vùng có nguy cơ tổn thương thần kinh. Không pha hoặc sử dụng thuốc khi không bảo đảm nhãn nhận diện, độ ổn định và vô khuẩn.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp: 01 ĐD/HS hoặc nhân viên chuyên môn khác được phép thực hiện, được đào tạo và phân công.
b) Nhân lực hỗ trợ: khi cần giữ tư thế an toàn hoặc hỗ trợ kỹ thuật; BS/nhóm cấp cứu được huy động khi có bất thường. Số lượng theo người bệnh và mức độ kỹ thuật.

5.2. Thuốc

Chuẩn bị đúng thuốc tiêm/truyền theo y lệnh. Với từng thuốc phải xác định tên hoạt chất/tên chế phẩm, nồng độ hoặc hàm lượng, liều và thể tích thực dùng, đường dùng, dạng dùng, dung môi, tương hợp, tốc độ, thời điểm, đơn vị và số lượng. Kiểm tra hạn dùng, chất lượng, điều kiện bảo quản và hướng dẫn sau pha.

Thuốc cấp cứu phản vệ phải sẵn sàng theo danh mục/phác đồ đã phê duyệt; đây là phương tiện dự phòng, không mặc định dùng cho mọi mũi tiêm. Không đưa liều cấp cứu rời rạc vào danh mục thuốc tiêm thường quy.

5.3. Vật tư

- Bơm tiêm, kim lấy thuốc và kim tiêm hoặc catheter vô khuẩn dùng một lần, đúng cỡ và tương thích chế phẩm; số lượng theo số lần thao tác, không dùng chung cho NB.

- Gạc/bông dùng một lần, dung dịch sát khuẩn da phù hợp, găng theo nguy cơ, dung dịch vệ sinh tay; dây truyền/đầu nối, băng cố định và garo khi kỹ thuật cần.

- Hộp chống đâm xuyên và bao bì chất thải đúng quy định, đặt thuận tiện và tách khỏi vùng sạch. Danh mục và đơn vị/số lượng chi tiết ghi tại phụ lục chuẩn bị.

5.4. Trang thiết bị

Khay/xe tiêm bố trí vùng sạch và vùng thu gom riêng; phương tiện đo sinh hiệu theo nhu cầu, cọc truyền và bơm/máy truyền khi có chỉ định. Phương tiện hồi sức phải có khả năng huy động ngay. Không đưa chi phí quản lý hoặc trang thiết bị không trực tiếp phục vụ kỹ thuật vào danh mục nguồn lực.

5.5. Người bệnh

- Giải thích mục đích, các bước, cảm giác có thể gặp, nguy cơ và dấu hiệu cần báo ngay; bảo đảm riêng tư và sự hợp tác.

- Kiểm tra dị ứng, thuốc đang dùng và tình trạng liên quan; lấy thông số sinh hiệu cần thiết theo thuốc/người bệnh.

- Chọn tư thế ổn định, vùng tiêm bộc lộ phù hợp, cơ thả lỏng khi tiêm bắp; trợ giúp khi có nguy cơ ngã hoặc cử động đột ngột.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Có y lệnh rõ ràng, thông tin nhận diện và dị ứng; phiếu công khai thuốc, ghi nhận thực hiện, theo dõi/chăm sóc và các biểu mẫu chuyên biệt khi cần. Nếu phát hiện thiếu hoặc mâu thuẫn, xác minh trước dùng thuốc. Y lệnh cấp cứu bằng lời được đọc lại và hoàn tất hồ sơ theo quy định bệnh viện.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Ước tính để thẩm định: khoảng 0,08–0,17 giờ cho chuẩn bị và thực hiện một mũi tiêm thông thường. Thời gian truyền và theo dõi phụ thuộc y lệnh, thuốc, người bệnh và diễn biến; ghi thời gian thực tế bằng giờ. Bệnh viện xác nhận định mức trước ban hành.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thủ thuật, vị trí tại giường hoặc khu thực hiện được quy định, đủ sáng, sạch và thuận tiện tiếp cận cấp cứu. Chuẩn bị thuốc ở vùng sạch; tránh nhiễm máu/dịch và tách khỏi chất thải.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

a) Kiểm tra NB: ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chẩn đoán/chỉ định, thuốc và vị trí cần thực hiện; đối chiếu y lệnh, liều, đường dùng, thời điểm và dị ứng.
b) Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp kỹ thuật; xác nhận thuốc, vật tư và phương tiện cấp cứu.
c) Đặt tư thế NB theo đường tiêm, vị trí và tình trạng; chưa thực hiện khi có điểm không bảo đảm. Không dùng số giường/buồng để thay thông tin định danh.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1 Kiểm tra và đối chiếu

Đọc y lệnh, nhận diện NB, kiểm tra dị ứng và làm rõ bất thường với BS/Khoa Dược. Kiểm tra thuốc và điều kiện sử dụng; giải thích, đánh giá ban đầu, chuẩn bị tư thế. Thực hiện 5 đúng khi chuẩn bị và ngay trước dùng tại NB.

6.2. Bước 2 Vệ sinh tay và chuẩn bị thuốc

Vệ sinh tay trước chuẩn bị; mang phòng hộ theo nguy cơ. Chuẩn bị tại vùng sạch, bảo vệ bộ phận vô khuẩn. Sát khuẩn nắp lọ/ống phù hợp, để khô; bẻ ống bằng gạc bảo vệ theo kỹ thuật. Mỗi lần vào lọ dùng kim và bơm tiêm vô khuẩn mới, không lưu kim ở lọ.

Lấy thuốc/pha theo dung môi, nồng độ, tương hợp và độ ổn định; kiểm tra liều và ghi nhãn nhận diện. Không tự pha trộn thuốc hoặc dùng chung lọ đơn liều cho nhiều NB; lọ đa liều quản lý theo hướng dẫn. Khi trì hoãn, bảo quản và đánh giá lại chất lượng, không đưa bơm đã pha trở lại bao bì đã mở để coi là vô khuẩn.

6.3. Bước 3 Chuẩn bị vùng tiêm

Đối chiếu lại tại NB, chọn vị trí, cỡ kim và tư thế theo kỹ thuật. Vệ sinh tay ngay trước thao tác vô khuẩn; dùng găng khi có chỉ định/nguy cơ, găng không thay thế vệ sinh tay. Làm sạch da khi bẩn, sát khuẩn bằng chế phẩm phù hợp và để khô; không chạm lại vùng đã sát khuẩn.

6.4. Bước 4 Thực hiện kỹ thuật theo đường dùng

- Trong da/dưới da/tiêm bắp: vị trí, góc, chiều dài kim, thể tích và thao tác theo tuổi, thể trạng, chế phẩm và QTKT đã duyệt; kiểm tra trước bơm theo đúng chế phẩm.

- TM: xác nhận đường truyền và cổng tiêm phù hợp; sát khuẩn đầu nối, bảo đảm tương hợp, tốc độ theo y lệnh và quan sát vị trí. Không cố bơm khi tắc hoặc đau/sưng.

- Thực hiện theo các quy trình và bảng kiểm liên quan. Thử trong da/lẩy da, truyền máu và lấy máu áp dụng quy trình riêng; bảng kỹ thuật chung không thay thế phác đồ chuyên biệt.

6.5. Bước 5 Theo dõi và thu gom tại chỗ

Quan sát đáp ứng và dấu hiệu bất thường trong khi dùng thuốc; ghi nhận lượng thực dùng. Kích hoạt cơ chế an toàn nếu có, bỏ ngay bơm/kim đã sử dụng vào hộp chống đâm xuyên; không đậy lại nắp, bẻ hoặc tháo kim bằng tay. Hộp đóng khi tới vạch đầy theo sản phẩm, không vượt quá 3/4 khi không có vạch.

6.6. Kết thúc quy trình

- Đánh giá tình trạng NB sau kỹ thuật, vị trí tiêm/truyền và đáp ứng; đặt tư thế an toàn, hướng dẫn dấu hiệu cần báo ngay.

- Hoàn thiện ghi chép và lưu hồ sơ: tên thuốc, liều/nồng độ, đường dùng, giờ thực tế, người thực hiện, đáp ứng, bất thường và xử trí; ghi lý do nếu chưa dùng hoặc dùng một phần. Không ký xác nhận trước thực hiện.

- Thu gom/phân loại theo quy định, vệ sinh dụng cụ/xe tiêm và vệ sinh tay. Chất thải lây nhiễm màu vàng, nguy hại không lây nhiễm màu đen, thông thường không tái chế màu xanh, được phép tái chế màu trắng theo danh mục.

- Bàn giao NB cho nhân viên/bộ phận tiếp theo khi cần: thuốc đã dùng/chưa dùng, dị ứng, đường truyền, đáp ứng và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

- Nhầm thuốc/liều/đường dùng/NB: dừng thao tác sai, đánh giá NB, báo ngay BS hoặc gọi cấp cứu; thực hiện chỉ định xử trí, giữ thông tin thuốc và báo cáo sự cố.

- Nghi phản vệ: ngừng tiếp xúc dị nguyên, gọi hỗ trợ và đánh giá hô hấp–tuần hoàn. Áp dụng phác đồ phản vệ đầy đủ; adrenalin tiêm bắp khi phản vệ từ độ II theo phác đồ và phạm vi được đào tạo. Hồi sinh tim phổi khi cần.

- Đau/sưng, nghi thoát mạch thuốc gây tổn thương mô: dừng tiêm/truyền, không bơm rửa, báo BS; giữ catheter để xử trí theo phác đồ thuốc trước quyết định rút. Không chườm/chích rạch thường quy.

- Tắc đường truyền: không cố bơm mạnh hoặc đẩy cục máu đông vào mạch; kiểm tra và xử trí theo quy trình. Nghi tổn thương mạch, thần kinh, gãy kim hoặc khó thở/quá tải khi truyền: dừng thao tác, gọi hỗ trợ và xử trí theo nguyên nhân.

- Kim/VSN gây phơi nhiễm: thực hiện sơ cứu và báo ngay đầu mối phơi nhiễm để đánh giá, dự phòng và theo dõi; không trì hoãn để hoàn tất thủ thuật hoặc hồ sơ.

7.2. Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

- Theo dõi tại vị trí tiêm và toàn trạng với tần suất/thời gian theo thuốc, đường dùng và nguy cơ; ghi đáp ứng, đau, tụ máu, chảy máu, dị ứng hoặc diễn biến hô hấp–tuần hoàn.

- Báo BS khi xuất hiện bất thường; kích hoạt cấp cứu nếu diễn biến nặng. Theo dõi phản vệ theo phác đồ; không dùng một thời gian theo dõi chung cho tất cả thuốc.

- Khi nghi phản ứng truyền máu tại phụ lục liên quan, áp dụng phác đồ truyền máu: ngừng truyền, gọi BS, bảo đảm chăm sóc NB và báo đơn vị cấp phát, giữ túi/dây và lấy mẫu theo chỉ định.

7.3. Biến chứng muộn

- Nhận diện viêm, nhiễm khuẩn/áp xe, tổn thương mô, đau kéo dài hoặc rối loạn cảm giác/vận động; báo BS để đánh giá và điều trị. Không tự dùng kháng sinh hoặc trích rạch.

- Duy trì kế hoạch theo dõi đường truyền và phơi nhiễm nghề nghiệp theo quy trình; đánh giá kết quả khắc phục, ADR/sự cố và đào tạo lại khi cần.

- Hướng dẫn NB liên hệ cơ sở y tế khi dấu hiệu bất thường xuất hiện sau rời nơi thực hiện; ghi và bàn giao hướng theo dõi phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế. Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; đối chiếu bản PDF do người dùng cung cấp. Căn cứ cấu trúc và thể thức.

2. Bộ Y tế - Vụ khoa học và Đào tạo, Kỹ thuật điều dưỡng, NXBYH học, Hà Nội 2005;

3. Bộ Y tế - Hướng dẫn kỹ thuật CSNB tập I; II, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2004;

4. Bộ Y tế. Hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành kèm Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012. Nguồn: https://kcb.vn/van-ban/tai-lieu-huong-dan-tiem-an-toan.html

5. Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế (v/v Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ).

6. Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 về quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế. Nguồn: https://vbpl.vn/hanoi/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=166211

7. Thông tư 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 hướng dẫn hoạt động truyền máu. Nguồn: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46980

8. WHO. Best practices for injections and related procedures toolkit, 2010; Guidelines on drawing blood, 2010. Nguồn: https://www.who.int/publications/i/item/9789241599252 và https://www.who.int/publications/i/item/9789241599221

9. WHO. Hand hygiene why how and when. Nguồn: https://www.who.int/docs/default-source/documents/health-topics/hand-hygiene-why-how-and-when-brochure.pdf

10. CDC. Preventing Unsafe Injection Practices. Nguồn: https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-safety/index.html

11. CDC. Vaccine Administration, chỉ áp dụng phần hướng dẫn vắc xin. Nguồn: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/imz-best-practices/vaccine-administration.html

12. CDC. Intravascular Catheter Related Infections, Summary of Recommendations. Nguồn: https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/intravascular-catheter-related-infections/summary-recommendations.html

13. Cancer Institute NSW eviQ. Extravasation management clinical procedure, tham khảo xử trí ban đầu thoát mạch thuốc gây tổn thương mô. Nguồn: https://www.eviq.org.au/clinical-resources/extravasation/4156-extravasation-management-clinical-procedure

PHỤ LỤC DANH MỤC CHUẨN BỊ

Danh mục dưới đây cho một lần thực hiện, tùy đường tiêm và người bệnh. Đây là danh mục chuẩn bị để thẩm định; bệnh viện xác nhận chế phẩm và số lượng thực tế, không dùng làm định mức kinh tế kỹ thuật khi chưa được phê duyệt.

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	ĐD/HS/nhân viên chuyên môn có năng lực và được phân công	Người	01
1.2	Nhân lực hỗ trợ khi cần	Người	Theo tình trạng NB
2	Thuốc tên hoạt chất nồng độ hàm lượng đường dùng dạng dùng		
2.1	Thuốc tiêm/truyền: ghi tên, nồng độ/hàm lượng, liều, đường/dạng dùng đúng y lệnh	Theo chế phẩm	Theo y lệnh
2.2	Dung môi pha/dịch truyền tương hợp, ghi tên và nồng độ theo hướng dẫn thuốc	mL	Theo y lệnh và chế phẩm
3	Vật tư sử dụng trực tiếp		
3.1	Bơm tiêm tương thích thuốc và thể tích, vô khuẩn dùng một lần	Cái	Theo số lần thao tác
3.2	Kim lấy thuốc và kim tiêm/catheter phù hợp đường dùng	Cái	Theo kỹ thuật
3.3	Gạc/bông dùng một lần, băng cố định khi cần	Miếng	Theo thao tác
3.4	Găng sạch/vô khuẩn theo yêu cầu kỹ thuật và nguy cơ	Đôi	Theo kỹ thuật
3.5	Dung dịch sát khuẩn da: ethanol/isopropyl 70% khi phù hợp; chế phẩm thay thế theo kỹ thuật	mL	Theo sản phẩm
3.6	Dung dịch vệ sinh tay hoặc xà phòng và phương tiện làm khô tay	Theo sản phẩm	Theo thao tác
3.7	Dây truyền, đầu nối phù hợp khi truyền	Bộ	Theo y lệnh
3.8	Hộp chống đâm xuyên và bao bì chất thải phù hợp	Cái	Sẵn có tại nơi thực hiện
4	Trang thiết bị sử dụng trực tiếp		
4.1	Khay/xe tiêm sạch	Bộ	01
4.2	Phương tiện đo sinh hiệu theo thuốc/người bệnh	Bộ	Theo yêu cầu theo dõi

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
4.3	Cọc truyền, bơm/máy truyền khi có chỉ định	Cái	Theo kỹ thuật

Phương tiện dự phòng: hộp thuốc phản vệ đúng danh mục và phương tiện hỗ trợ hô hấp–tuần hoàn có thể huy động ngay. Thuốc cấp cứu dùng theo phác đồ chuyên biệt, không cộng mặc định vào thuốc tiêu hao của mọi mũi tiêm.

PHỤ LỤC: ĐH.QT.15.ĐD:01

TIÊU CHUẨN TIÊM AN TOÀN TẠI BV ĐA KHOA NHẬT TÂN

Bơm kim tiêm vô khuẩn.Có sử dụng xe tiêm khi đi tiêm.

Có sử dụng khay tiêm khi đi tiêm.

Có hộp đựng vật sắc nhọn ở gần nơi tiêm.

Rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi chuẩn bị thuốc.

Rửa tay, sát khuẩn tay nhanh sau khi chuẩn bị thuốc.

Mang găng khi tiêm (khi cần).

Kim lấy thuốc đảm bảo vô khuẩn.

Tiêm thuốc đúng chỉ định.

Tiêm thuốc đúng thời gian.

Tiêm đúng vị trí.

Tiêm đúng góc kim so với mặt da.

Tiêm đúng độ sâu.

14

Kiểm tra trước bơm phù hợp đường dùng/chế phẩm; tiêm vắc xin không hút kiểm tra.

15

Thực hiện tốc độ và thao tác theo thuốc/kỹ thuật, không áp dụng hai nhanh một chậm cho mọi mũi tiêm.

16

Không đậy lại nắp kim sau sử dụng.

Cô lập ngay bơm kim tiêm đã nhiễm khuẩn trong hộp an toàn.

PHỤ LỤC: ĐH.QT.15-ĐD:02

QUY TRÌNH RỬA TAY THƯỜNG QUY

STT	Các bước tiến hành
1	Đứng trước bồn rửa tay, tháo bỏ trang sức ở tay
2	Mở nước và điều chỉnh cần gạt, để nước không bắn ra ngoài
3	Lấy xà phòng và chà 2 lòng bàn tay vào nhau cho xà phòng dàn đều
4	Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại
5	Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ trong ngón tay
6	Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại
7	Dùng lòng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại
8	Xoay đều đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và làm khô tay

Chú ý: rửa tay bằng xà phòng và nước trong khoảng 40–60 giây cho toàn bộ thao tác; làm khô bằng khăn dùng một lần, đóng vòi không làm tái nhiễm tay.

PHỤ LỤC: ĐH.QT.15.ĐD:03

Sát khuẩn tay bằng dung dịch chứa cồn khoảng 20–30 giây cho toàn bộ thao tác, tới khi khô; lượng đủ phủ mọi bề mặt theo sản phẩm. Khi tay bẩn nhìn thấy, rửa bằng xà phòng và nước.

QUY TRÌNH SÁT KHUẨN TAY NHANH BẰNG DUNG DỊCH CHỨA CỒN

STT	Các bước tiến hành
1	Lấy đủ dung dịch chứa cồn theo sản phẩm, phủ mọi bề mặt tay; chà lòng bàn tay vào nhau.
2	Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại
3	Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ trong ngón tay
4	Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại
5	Dùng lòng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại
6	Xoay đều đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Chà sát tay cho đến khi khô tay

BVĐK NHẬT TÂN PHỤ LỤC: ĐH.QT.15.ĐD: 04

Khoa.....

PHIẾU QUAN SÁT CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN TIÊM AN TOÀN

I. ĐÁNH GIÁ DỤNG CỤ TIÊM: (đánh dấu vào 1 ô thích hợp nhất):

1. Loại bơm kim tiêm: □ Dùng một lần □ Có cơ chế an toàn/tự hủy. Ghi loại thiết bị: .....

2. Bao bì, hạn dùng, nguồn gốc và cỡ kim phù hợp: □ Đạt □ Không đạt. Ghi bất thường: .....

3. Có xe tiêm/ khay tiêm khi đi tiêm: có không

4. Hộp vật sắc nhọn phù hợp tiêu chuẩn, đặt gần nơi tiêm và chưa tới vạch đầy: □ Có □ Không.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ THỰC HÀNH TIÊM AN TOÀN

5. Rửa tay/sát khuẩn tay trước khi chuẩn bị thuốc: có không

6. Rửa tay/sát khuẩn tay trước khi đưa kim qua da có không

7. Mang găng khi tiêm tĩnh mạch/truyền dịch/truyền máu và bệnh nhiễm: có không

8. Kim lấy thuốc đảm bảo vô khuẩn:. có không

9. Kim tiêm đảm bảo vô khuẩn trước khi tiêm : có không (không chạm vào bất cứ vật gì)

10. Tiêm thuốc đúng chỉ định (tên thuốc, liều lượng, đường tiêm, thời gian tiêm thuốc. người quan sát kiểm tra y lệnh).

11. Xác định đúng vị trí tiêm (vị trí, góc kim, độ sâu thích hợp) có không nếu không, ghi cụ thể:.....

12. Kiểm tra trước bơm thuốc phù hợp đường dùng và chế phẩm: □ Đạt □ Không đạt □ Không áp dụng. Không áp dụng hút kiểm tra thường quy cho mọi thuốc; tiêm vắc xin không cần hút kiểm tra.

13. Không đậy lại nắp kim sau sử dụng: □ Đạt □ Không đạt.

14. Cô lập ngay bơm/ kim tiêm đã sử dụng trong hộp an toàn: có không

15. Có dùng panh/ kẹp khi đi tiêm: có không nếu có: tình trạng của panh/ kẹp: vô khuẩn: sạch: bẩn:

- Sử dụng panh/ kẹp để làm gì (người quan sát ghi rõ việc sử dụng panh/ kẹp): .... 16. Rơi vãi bơm kim tiêm: có không nếu có, người quan sát ghi cụ thể vị trí rơi vãi.....

Ngày..... tháng .....năm 202…

Họ tên người giám sát Họ tên người quan sát

PHỤ LỤC: ĐH.QT15.ĐD: 05

QUY TÌNH KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TEST TRONG DA; LẢY DA

Tiêm trong da đưa lượng nhỏ chế phẩm vào lớp bì. Liều, nồng độ và thể tích theo chế phẩm hoặc thử nghiệm được chỉ định; không mặc định 0,1 mL cho mọi kỹ thuật.

Thử trong da và lẩy da chỉ thực hiện khi có y lệnh, nồng độ không gây kích ứng và quy trình của thuốc/dị nguyên cụ thể; chuẩn bị cấp cứu. Không áp dụng công thức pha hoặc bảng đọc chung cho mọi thuốc. Kết quả âm tính không loại trừ phản vệ.

I. CHỈ ĐỊNH TIÊM TRONG DA

- Tiêm trong da được chỉ định trong các trường hợp sau:

- Tiêm một số loại vaccin phòng bệnh, ví dụ: tiêm vaccin BCG phòng lao cho trẻ sơ sinh.

- Thử nghiệm tuberculin để đánh giá nhiễm lao theo hướng dẫn chuyên biệt; không gọi là thử phản ứng BCG.

- Thử nghiệm da với thuốc chỉ khi có chỉ định và quy trình chuyên biệt do bác sĩ phụ trách; không thử thường quy cho tất cả thuốc/kháng sinh.

II. DỤNG CỤ

- Hai khay chữ nhật sạch, trụ cắm 1kìm Kocher.

- cồn 70% , cốc đựng bông cần.

- Thuốc theo chỉ định.

- Hộp chống sốc, huyết áp, ống nghe.

- Bơm kim tiêm 1 mL.

- Hộp đựng vật sắc nhọn, túi đựng đồ bẩn.

III. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

STT	Các bước thực hiện	Mục đích	Yêu cầu
1	Xác nhận y lệnh, thuốc/dị nguyên và quy trình thử chuyên biệt	Đúng chỉ định	Bác sĩ quyết định; không thử thường quy mọi thuốc
2	Nhận diện bằng hai thông tin, khai thác dị ứng và thuốc đang dùng	An toàn người bệnh	Bác sĩ đánh giá chống chỉ định và ảnh hưởng kết quả
3	Chuẩn bị phương tiện cấp cứu, thuốc/chứng và dụng cụ vô khuẩn	Phòng tai biến	Đúng loại thử nghiệm; sẵn sàng xử trí phản vệ

STT	Các bước thực hiện	Mục đích	Yêu cầu
4	Kiểm tra tên, nồng độ ban đầu, dung môi và công thức pha	Đúng chế phẩm	Theo quy trình của đúng thuốc/dị nguyên được duyệt
5	Pha nồng độ thử theo chỉ định, kiểm tra và ghi nhãn	Tránh nhầm và kích ứng	Không dùng một công thức đơn vị quốc tế chung cho mọi thuốc
6	Xác định vị trí, vệ sinh tay và sát khuẩn phù hợp	Vô khuẩn	Chọn vùng da phù hợp, để khô
7	Đưa kim vào lớp bì theo kỹ thuật chuyên biệt	Đúng đường	Mặt vát ngửa, góc nông theo chế phẩm và quy trình
8	Tiêm thể tích được chỉ định; thực hiện chứng khi quy trình yêu cầu	Kết quả có thể diễn giải	Không mặc định một thể tích/chứng cho mọi thử nghiệm
9	Bỏ kim ngay; đánh dấu tên thuốc, vị trí và thời điểm	An toàn, truy xuất	Không chà xát vùng thử
10	Theo dõi, đo tổn thương và đọc đúng thời điểm	Phát hiện phản ứng	Ghi kích thước và chứng; bác sĩ diễn giải
11	Ghi hồ sơ, vệ sinh tay, báo kết quả và bất thường	Hoàn tất	Kết quả âm tính không loại trừ phản vệ

Chú ý: đọc kết quả theo thời điểm và tiêu chí của từng thử nghiệm, ghi kích thước tổn thương, chứng và triệu chứng; bác sĩ diễn giải. Không dùng một mốc 15 phút cho mọi kỹ thuật, đặc biệt không dùng cho tuberculin.

(+) Dương tính

(-) Âm tính

Không rõ ràng

- Cách đọc kết quả:

Nội dung	Ghi nhận	Yêu cầu diễn giải
Tên thử nghiệm và thuốc/dị nguyên	Ghi tên, nồng độ, thể tích, vị trí, thời điểm	Theo quy trình của đúng chế phẩm
Chứng và tổn thương da	Ghi chứng, kích thước sẩn/ban theo mm và triệu chứng	Không dùng mức cộng (+) chung thay tiêu chí riêng

Nội dung	Ghi nhận	Yêu cầu diễn giải
Kết luận	Bác sĩ ghi kết luận và hướng dẫn tiếp theo	Âm tính không loại trừ phản vệ; không tự quyết định dùng thuốc

IV. AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

NGUY CƠ – TAI BIẾN	PHÒNG NGỪA- XỬ TRÍ
Nhầm lẫn thuốc	Thực hiện đúng 3 kiểm tra, 5 đối chiếu
Sốc phản vệ: do phản ứng của cơ thể đối với thuốc	Hỏi tiền sử dị ứng. Chuẩn bị hộp chống sock phản vệ Phát hiện sớm, xử trí kịp thời khi sock xuất hiện
Phản ứng thuốc biểu hiện mẩn ngứa hoặc sốt	Ngưng ngay, báo bác sĩ nếu thử phản ứng

BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST TRONG DA

STT	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH	CÓ	KHÔNG
1	Nhận định tình trạng người bệnh		
2	Nhận định kiến thức về thuốc của người bệnh		
3	Kiểm tra đối chiếu		
4	Chuẩn bị người bệnh		
5	Rửa tay		
6	Xác định vị trí tiêm		
7	Mang găng tay		
8	Sát khuẩn rộng vùng tiêm		
9	Sát khuẩn lại tay		
10	Tay căng da, đâm kim góc 10° so với mặt da		
11	Tiêm đúng thể tích và nồng độ theo thử nghiệm/chế phẩm được chỉ định		
12	Bơm thuốc từ từ quan sát sắc mặt người bệnh		
13	Rút kim theo hướng đâm vào		
14	Cô lập bơm kim tiêm		
15	Tháo găng tay		

STT	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH	CÓ	KHÔNG
16	Cho người bệnh nằm lại tiện nghi, theo dõi sự đáp ứng thuốc của người bệnh		
17	Thu dọn dụng cụ		
18	Rửa tay		
19	Ghi hồ sơ		

QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TEST LẪY DA

I. DỤNG CỤ

- Hai khay chữ nhật sạch, trụ cắm 1kìm Kocher.
- cồn 70% , cốc đựng bông cần.
- Thuốc theo chỉ định.
- Hộp chống sốc, huyết áp, ống nghe.
- Bơm kim tiêm 1 mL.
- Hộp đựng vật sắc nhọn, túi đựng đồ bẩn.

II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

STT	Các bước thực hiện	Mục đích	Yêu cầu
1	Xác nhận chỉ định, quy trình thuốc/dị nguyên và các chứng	Đúng thử nghiệm	Bác sĩ đánh giá và chỉ định
2	Nhận diện, giải thích, kiểm tra dị ứng và thuốc ảnh hưởng kết quả	An toàn	Ít nhất hai thông tin; sẵn sàng cấp cứu
3	Chuẩn bị thuốc/dị nguyên, chứng và dụng cụ lẩy da vô khuẩn	Đúng nồng độ	Theo quy trình chuyên biệt, không pha chung công thức
4	Vệ sinh tay, chọn và chuẩn bị vùng da; đánh dấu	Tránh nhầm	Để khô; khoảng cách theo quy trình
5	Đặt giọt thuốc/dị nguyên và chứng theo hướng dẫn	Có đối chứng	Dụng cụ riêng cho từng vị trí
6	Lẩy da đúng hướng dẫn thiết bị, tránh chảy máu	Đúng kỹ thuật	Không dùng một góc kim chung cho mọi dụng cụ
7	Thu gom vật sắc nhọn, theo dõi và dặn không chà xát	Phòng tai biến	Báo ngay bất thường

STT	Các bước thực hiện	Mục đích	Yêu cầu
8	Đọc đúng thời điểm, đo tổn thương và chứng; bác sĩ kết luận	Diễn giải	Ghi kích thước mm, không tự suy kết quả
9	Ghi hồ sơ, báo kết quả, vệ sinh tay	Hoàn tất	Xác định hướng xử trí tiếp theo bằng y lệnh

Chú ý:

- Đọc kết quả theo hướng dẫn của từng thử nghiệm và các chứng phù hợp; bác sĩ phụ trách diễn giải, không mặc định 20 phút cho mọi chế phẩm.

- Cách ghi kết quả vào hồ sơ:

(+) Dương tính

(-) Âm tính

Không rõ ràng

- Cách đọc kết quả:

Nội dung	Ghi nhận	Yêu cầu diễn giải
Tên thử nghiệm và thuốc/dị nguyên	Ghi tên, nồng độ, thể tích, vị trí, thời điểm	Theo quy trình của đúng chế phẩm
Chứng và tổn thương da	Ghi chứng, kích thước sẩn/ban theo mm và triệu chứng	Không dùng mức cộng (+) chung thay tiêu chí riêng
Kết luận	Bác sĩ ghi kết luận và hướng dẫn tiếp theo	Âm tính không loại trừ phản vệ; không tự quyết định dùng thuốc

PHỤ LỤC: ĐH.QT.15.ĐD: 06

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM DƯỚI DA

Tiêm dưới da là dùng bơm kim tiêm đưa một lượng dung dịch thuốc vào tổ chức mô liên kết dưới da của bệnh nhân.

I. CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH

1. Chỉ định:

Thuốc có chỉ định và dạng bào chế cho phép dùng dưới da, như insulin phù hợp chế phẩm; kiểm tra nồng độ và thiết bị tương thích.

2. Chống chỉ định:

Không dùng đường dưới da với chế phẩm không được phép dùng đường này; đánh giá vị trí tiêm, dị ứng và các thận trọng theo thuốc.

II. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

- Hai khay chữ nhật sạch, trụ cắm 1kìm Kocher.

- cồn 70%, cốc đựng bông cần.

- Thuốc theo chỉ định.

- Hộp chống sốc, huyết áp, ống nghe.

- Bơm tiêm/kim hoặc bút tiêm tương thích chế phẩm và liều; insulin dùng thiết bị đúng nồng độ. Không áp dụng bơm 3–5 mL cho mọi thuốc dưới da.

- Hộp đựng vật sắc nhọn, túi đựng đồ bẩn.

III. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

STT			Các bước thực hiện
Ý nghĩa quy trình Tiêu chuẩn đạt được			
1	Kiểm tra y lệnh. Thông báo giải thích cho NB	Đảm bảo nguyên tắc dùng thuốc	Đảm bảo 5 đúng: Tạo được thiện chí giữa điều dưỡng và NB

STT			Các bước thực hiện
2	Đeo khẩu trang, rửa tay, chuẩn bị thuốc và dụng cụ	Đảm bảo nguyên tắc khi chăm sóc NB	Rửa tay thường quy, dụng cụ đúng, đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, để thuận tiện
3	Kiểm tra lại thuốc, sát khuẩn nơi bẻ ống thuốc (ống dung môi) dung bông khô bẻ ống thuốc, hoặc mở nắp sát khẩn đầu lọ thuốc	Đảm bảo an toàn cho NB	Đúng thuốc theo y lệnh Không làm nát ống thuốc ống
4	Dùng bơm tiêm lấy thuốc (thay kim lấy thuốc nếu cần)	Chuẩn bị thuốc để tiêm cho NB	NB Lượng thuốc đúng theo y lệnh không đổ ra ngoài
5	Thay kim tiêm (nếu cần), đuổi khí, đặt vào khay vô khuẩn. Có phiếu thuốc đi kèm theo	Hạn chế tai biến và tránh nhầm lẫn	Đảm bảo vô khuẩn Kim tiêm có nắp đặp Bơm tiêm không có bọt khí
6	Đem dụng cụ đến bên giường NB để nơi thuận tiện	Thuận lợi trong khi tiến hành thao tác	Dụng cụ để bên phải nếu thuận tay phải và ngược lại
7	Đặt NB ở tư thế thuận tiện. Bộc lộ vùng tiêm, xác định vị trí tiêm. Mang găng tay sạch	Thuận tiện khi tiến hành thao tác. Phòng tránh lây nhiễm	Dưới cơ delta 1/3 giữa mặt trước ngoài đùi Hai bên rốn khoảng 5 cm, hai bên bả vai
8	Sát khuẩn vị trí tiêm. Chuẩn bị bông cồn. Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh	Hạn chế nhiễm trùng	Sát khuẩn từ trong ra ngoài khoảng 5 cm bằng cồn 70% (hoặc cồn Iode) dến khi sạch
9	Nâng nếp da và chọn góc theo cỡ kim, mô dưới da và chế phẩm	Đúng lớp dưới da	Thực hiện theo quy trình của thuốc, không mặc định độ sâu 1 cm.
10	Thực hiện kiểm tra và bơm thuốc theo hướng dẫn chế phẩm	Đúng thuốc và kỹ thuật	Không hút kiểm tra thường quy mọi thuốc; theo hướng dẫn insulin, vắc xin hoặc chế phẩm cụ thể.
11	Hết thuốc rút kim, kéo chệch da, sát khuẩn lại nơi tiêm	Đảm bảo đúng kỹ thuật Hạn chế nhiễm khuẩn	Không trào thuốc ra ngoài nơi đâm kim
12	Giúp NB tiện nghi. Hướng dẫn những điều cần thiết	thiết Đề phòng tai biến, phát hiện và xử trí kịp thời khi có tai biến xảy ra	Dặn NB không được chà sát vào vùng tiêm. Nếu có mảng ngứa, khó chịu thì phải báo ngay cho điều dưỡng

STT			Các bước thực hiện
13	Thu dọn dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ	Tiện việc xử lý dụng cụ, chịu trách nhiệm chuyên môn, pháp lý	Dụng cụ phải bỏ vào nơi đúng quy định, rửa tay thường quy

IV. AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

NGUY CƠ – TAI BIẾN	PHÒNG NGỪA- XỬ TRÍ
Áp xe tại chỗ: chỗ tiêm tấy đỏ, sưng nóng, toàn thân có thể sốt hoặc không	Báo bác sĩ, đánh giá vùng tiêm và toàn trạng; chăm sóc và điều trị theo chỉ định. Không tự dùng kháng sinh, chườm nóng hoặc chích áp xe.
Gãy kim, quằn kim do NB giãy giụa mạnh hoặc do tiêm không đúng kỹ thuật	Dừng thao tác, giữ vùng tổn thương ổn định, báo bác sĩ để lấy kim an toàn; không dò tìm kim sâu trong mô.
NB bị sốc: do bơm thuốc quá nhanh hoặc NB quá sợ hãi, NB bị đau không chịu được.	Ngừng thao tác, gọi hỗ trợ, đánh giá hô hấp–tuần hoàn và ý thức; xử trí theo nguyên nhân và phác đồ cấp cứu. Không coi mọi sốc là do sợ hoặc bơm nhanh.
Các tai biến do thuốc: - NB đau, áp xe vô khuẩn: do thuốc tiêm vào không hấp thụ được hoặc hấp thụ rất chậm. - Phát hiện: chỗ tiêm sưng, nóng, đỏ	Báo bác sĩ, đánh giá vùng tiêm và toàn trạng; chăm sóc và điều trị theo chỉ định. Không tự dùng kháng sinh, chườm nóng hoặc chích áp xe.

BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM DƯỚI DA

STT	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH	CÓ	KHÔNG
1	Nhận định tình trạng người bệnh		
2	Nhận định kiến thức về thuốc của người bệnh		
3	Kiểm tra đối chiếu		
4	Chuẩn bị người bệnh		
5	Rửa tay		
6	Xác định vị trí tiêm		
7	Mang găng tay		
8	Sát khuẩn rộng vùng tiêm		
9	Sát khuẩn lại tay		
10	Tay căng da, đâm kim góc 45° so với mặt da		
11	Kiểm tra theo hướng dẫn chế phẩm; không hút kiểm tra thường quy mọi thuốc dưới da		
12	Bơm thuốc từ từ quan sát sắc mặt người bệnh		
13	Rút kim theo hướng đâm vào sát khuẩn lại vị trí tiêm		
14	Cô lập bơm kim tiêm		
15	Tháo găng tay		
16	Cho người bệnh nằm lại tiện nghi, theo dõi sự đáp ứng thuốc của người bệnh		
17	Thu dọn dụng cụ		
18	Rửa tay		
19	Ghi hồ sơ		

PHỤ LỤC: ĐH.QT.15.ĐD: 07

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH

I. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

1. Chỉ định:

- Thuốc có chỉ định dùng tĩnh mạch, đúng dạng bào chế và mục tiêu điều trị; lựa chọn đường truyền theo đặc tính thuốc và người bệnh.

- Thuốc kích ứng hoặc gây tổn thương mô cần đường truyền, nồng độ, tốc độ và theo dõi phù hợp theo chỉ định, không tự chọn vì thuốc không tiêm được đường khác.

- Những thuốc không được tiêm bắp hoặc tiêm dưới da chỉ được tiêm tĩnh mạch.

- Những dung dịch đẳng trương, ưu trương cần đưa vào cơ thể bệnh nhân với khối lượng thuốc khá lớn.

- Truyền máu/chế phẩm máu thực hiện theo quy trình truyền máu riêng; không dùng bảng tiêm thuốc tĩnh mạch thay thế.

- Các loại huyết thanh trị liệu.

2. Chống chỉ định:

- Không dùng tĩnh mạch với chế phẩm không được phép dùng đường này. Thuốc ảnh hưởng huyết động, bao gồm adrenalin, cần chỉ định, cách pha và theo dõi theo phác đồ chuyên biệt; không suy từ một triệu chứng đơn lẻ để quyết định đường dùng.

- Những loại thuốc dầu: testosteron…

II. DỤNG CỤ

- Hai khay chữ nhật sạch, trụ cắm 1kìm Kocher.

- cồn 70% , hộp đựng gòn vô khuẩn

- Thuốc theo chỉ định,

- Hộp chống sốc, huyết áp, ống nghe.

- Bơm kim tiêm 5 mL - 10 mL

- Hộp đựng vật sắc nhọn, túi đựng đồ bẩn

- Dây garo.

III. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

STT			Các bước thực hiện
Ý nghĩa quy trình Tiêu chuẩn đạt được 1	Kiểm tra y lệnh. Thông báo giải thích cho NB	Đảm bảonguyên tắc dùng thuốc	Đảm bảo 5 đúng: Tạo được thiện chí giữa điều dưỡng và NB
2	Đeo khẩu trang, rửa tay, chuẩn bị thuốc và dụng cụ	Đảm bảo nguyên tắc khi chăm sóc NB	Rửa tay thường quy, dụng cụ đúng, đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, để thuận tiện.
3	Kiểm tra lại thuốc, sát khuẩn nơi bẻ ống thuốc (ống dung môi) dung bông khô bẻ ống thuốc, hoặc mở nắp sát khẩn đầu lọ thuốc	Đảm bảo an toàn cho NB	Đúng thuốc theo y lệnh Không làm nát ống thuốc, ống dung môi
4	Dùng bơm tiêm lấy thuốc (thay kim lấy thuốc nếu cần)	Chuẩn bị thuốc để tiêm cho NB	NB Lượng thuốc đúng theo y lệnh không đổ ra ngoài
5	Thay kim tiêm (nếu cần), đuổi khí, đặt vào khay vô khuẩn. Có phiếu thuốc đi kèm theo	Hạn chế tai biến và tránh nhầm lẫn	Đảm bảo vô khuẩn Kim tiêm có nắp đặp Bơm tiêm không có bọt khí
6	Đem dụng cụ đến bên giường NB để nơi thuận tiện	Thuận lợi trong khi tiến hành thao tác	Dụng cụ để bên tay thuận
7	ĐểNB ở tư thế thuận tiện. Bộc lộ vùng tiêm, lót gối dưới vàng tiêm. Mang găng tay sạch	Thuận tiện khi tiến hành thao tác. Phòng tránh lây nhiễm	Chọn tĩnh mạch nổi rõ, không xơ cứng, ít di động. NB nằm hoặc ngồi

STT			Các bước thực hiện
8	Buộc dây garo, sát khuẩn vị trí tiêm dọc theo tĩnh mạch. Chuẩn bị bông cồn. Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh Để tĩnh mạch nổi rõ hơn. Hạn chế nhiễm trùng Dây garo đặt tại vị trí đâm kim khoảng 5 cm, dán hoặc thắt sao cho dễ mở. Sát khuẩn từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài rộng khoảng 5 cm bằng cồn 70% , sát khuẩn đến khi	Để tĩnh mạch nổi rõ hơn. Hạn chế nhiễm trùng	Dây garo đặt tại vị trí đâm kim khoảng 5 cm, dán hoặc thắt sao cho dễ mở. Sát khuẩn từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài rộng khoảng 5 cm bằng cồn 70%, sát khuẩn đến khi sạch. Thân kim vào trong lòng tĩnh mạch ít nhất 0,5 cm
9	Một tay căng da, một tay cầm bơm tiêm dâm kim chếch 15–30° so với mặt da, hướng mũi kim theo đường đi của tĩnh mạch. Rút nhẹ nòng bơm tiêm, thấy máu vào đốc kim	Để tĩnh mạch nổi rõ hơn. Hạn chế nhiễm trùng	Căng da ngược chiều với chiều đâm kim, mũi vát hướng lên trên, có máu vào đốc kim. Thân kim vào trong tĩnh mạch ít nhất 0,5 cm
10	Mở dây garo, bơm thuốc từ từ, quan sát sắc mặt NB	Đề phòng tai biến	Mở garo nhẹ nhàng không làm lệch kim ra ngoài tĩnh mạch. Không phồng khi bơm thuốc
11	Hết thuốc rút kim, kéo chệch da, sát khuẩn lại nơi tiêm	Đảm bảo đúng kỹ thuật	Không gây chảy máu
12	Giúp NB tiện nghi. Hướng dẫn những điều cần thiết	Đề phòng tai biến, phát hiện và xử trí kịp thời khi có tai biến xảy ra	Dặn NB nghỉ ngơi ít nhất 15 phút. Nếu có bất thường:ngứa, khó chịu thì báo với nhân viên y tế
13	Thu dọn dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ	Tiện việc xử lý dụng cụ, chịu trách nhiệm chuyên môn, pháp lý	Dụng cụ bỏ đúng nơi quy định rửa tay thường quy, ghi hồ sơ

IV. AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

TAI BIẾN – TRIỆU TRỨNG	PHÒNG NGỪA- XỬ TRÍ
Tắc kim	Dừng sử dụng, kiểm tra nguyên nhân; không bơm mạnh hoặc đẩy cục máu đông vào mạch. Thiết lập đường truyền khác khi cần theo quy trình.

TAI BIẾN – TRIỆU TRỨNG	PHÒNG NGỪA- XỬ TRÍ
Phồng nơi tiêm	Dừng tiêm/truyền, báo bác sĩ; không bơm rửa. Khi nghi thuốc gây tổn thương mô thoát mạch, giữ catheter để xử trí theo phác đồ thuốc trước quyết định rút; không chườm nóng hoặc chích rạch thường quy.
Bệnh nhân bị sốc hoặc bị ngất	Ngừng thao tác, gọi hỗ trợ, đánh giá hô hấp–tuần hoàn và ý thức; xử trí theo nguyên nhân và phác đồ cấp cứu. Không coi mọi sốc là do sợ hoặc bơm nhanh.
- Tắc mạch do để khí lọt vào thành mạch trong khi tiêm. - Phát hiện: mặt NB tái, ho sặc sụa, khó thở hoặc ngừng thở đột ngột	Ngừng thao tác, gọi hỗ trợ, đánh giá hô hấp–tuần hoàn và ý thức; xử trí theo nguyên nhân và phác đồ cấp cứu. Không coi mọi sốc là do sợ hoặc bơm nhanh.
Đâm nhầm vào động mạch: Khi bơm thuốc vào thấy NB kêu đau nóng ở bàn chân	Ngừng tiêm và rút kim vì có thể đâm nhầm vào động mạch.
Gây hoại tử: chỗ tiêm nóng, đỏ, đau; lúc đầu cứng, sau mềm nhũn giống ổ áp xe	Dừng tiêm/truyền, báo bác sĩ; không bơm rửa. Khi nghi thuốc gây tổn thương mô thoát mạch, giữ catheter để xử trí theo phác đồ thuốc trước quyết định rút; không chườm nóng hoặc chích rạch thường quy.
Nhiễm khuẩn toàn thân, tại chỗ:sốt cao, rét run, tình trạng nhiễm khuẩn nặng, cấy máu (+) chỗ sưng, nóng do đau.	Báo bác sĩ, thực hiện theo y lệnh

BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH

STT	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH	CÓ	KHÔNG
1	Nhận định tình trạng người		
2	Nhận định kiến thức về thuốc của người bệnh		
3	Kiểm tra đối chiếu		
4	Chuẩn bị người bệnh		
5	Rửa tay		
6	Xác định vị trí tiêm		
7	Mang găng tay (nếu cần)		
8	Cột garo cách vị trí tiêm 10 – 15 cm		
9	Sát khuẩn rộng vùng tiêm		
10	Sát khuẩn lại tay		
11	Tay căng da, đâm kim góc 30–40° so với mặt da, luồn kim vào tĩnh mạch		
12	Rút nòng bơm tiêm kiểm tra máu		
13	Tháo garo		
14	Bơm thuốc từ từ quan sát sắc mặt người bệnh		
15	Rút kim theo hướng đâm vào, sát khuẩn lại vị trí tiêm		
16	Cố định kim		
17	Tháo găng tay (nếu đi gang)		
18	Cho người bệnh nằm lại tiện nghi, theo dõi sự đáp ứng thuốc của người bệnh		
19	Thu dọn dụng cụ		
20	Rửa tay		
21	Ghi hồ sơ		

PHỤ LỤC: ĐH.QT.15.ĐD:08

QUY TRÌNH
TIÊM TRUYỀN DUNG DỊCH NHỎ GIỌT TĨNH MẠCH

I. ĐẠI CƯƠNG

- Kỹ thuật tiêm truyền tĩnh mạch được thực hiện bằng kim catheter tĩnh mạch ngoại vi là phương pháp tiêm, truyền tĩnh mạch sử dụng loại kim làm bằng ống nhựa mềm luồn vào trong lòng tĩnh mạch.

- Catheter ngoại biên cho phép duy trì đường truyền theo chỉ định nhưng vẫn có nguy cơ di lệch, thoát mạch, viêm và nhiễm khuẩn. Đánh giá vị trí, chức năng và nhu cầu duy trì thường xuyên.

- Hiện tại kỹ thuật đặt kim catheter tĩnh mạch ngoại vi được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở điều trị, mang lại nhiều tiện ích và hiệu quả cho cả NB và điều dưỡng.

II. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

1. Chỉ định:

- Các trường hợp NB cần hồi sức cấp cứu: sốc, trụy mạch, suy hô hấp, hôn mê, ngừng tuần hoàn…

- Tiêm, truyền thuốc qua đường tĩnh mạch

- Truyền dịch liên tục - Truyền dịch ngắt quảng

- Truyền máu và các chế phẩm của máu - Trước khi làm thủ thuật, phẫu thuật, các thuốc cản quang…

- Các trường hợp cần nuôi dưỡng tĩnh mạch ngắn ngày

2. Chống chỉ định:

- Vùng tĩnh mạch bị tổn thương, bị nhiễm khuẩn, bầm tím , bỏng …..

III. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

1. Dụng cụ vô khuẩn:

- Bộ dụng cụ tiêm truyền vô khuẩn (2 khay chữ nhật, 2 khay hạt đậu, 1 ống cắm pank, 2 pank, 1 kéo, 1hộp bông).

- Bơm tiêm, kim catheter (cỡ phù hợp với NB), kim lấy thuốc, dây nối, ba chạc, dây truyền.

2. Dụng cụ khác:

- Gối kê tay, kéo, băng dính, dây garo, găng tay vô khuẩn;

- Dung dịch sát khuẩn da theo hướng dẫn kỹ thuật và chế phẩm; để khô trước chọc. Trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 2 tháng, cần hướng dẫn riêng; không dùng mặc định chlorhexidine 4% cho mọi trường hợp.

- Hộp chống sốc, thuốc hoặc dịch truyền theo y lệnh (nếu có), nước cất, dung dịch Natriclorid 0,9%;

- Hộp kháng thủng đựng vật sắc nhọn, xô đựng chất thải y tế.

IV. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

STT			Các bước thực hiện
Ý nghĩa quy trình Tiêu chuẩn đạt được 1	Kiểm tra y lệnh. Thông báo, giải thích và hướng dẫn NB những điều cần thiết. Đo DHST, xác định vị trí truyền dịch	Đảm bảo nguyên tắc khi truyền dịch. Giúp NB hợp tác trong khi truyền truyền dịch	Đảm bảo 5 đúng: Tạo được thiện chí giữa điều dưỡng và NB
2	Đeo khẩu trang, rửa tay, chuẩn bị dụng cụ. Đem dụng cụ đến bên giường NB để nơi thuận tiện	Đảm bảo nguyên tắc chung khi chăm sóc NB	Rửa tay thường quy, dụng cụ đúng, đầy đủ, dịch truyền có kiểm tra, đối chiếu
3	Kiểm tra dịch truyền, mở nắp và sát khuẩn nút chai. Khóa dây truyền và cắm vào chai dịch	Tránh nhầm lẫn, thuận tiện khi đuổi khí	Dịch truyền đúng y lệnh. Khóa chặt dây truyền. Kim lấy dịch cắm thẳng vào chai
4	Treo chai lên cọc truyền, chỉnh dịch trong bầu đếm giọt, đuổi khí, khóa lại. Cắt băng dính	Trách tắc mạch thuận tiện khi cố định kim truyền	Lượng dịch trong bầu đếm giọt khoảng 1/2 đến 2/3 bầu. Dây truyền không còn bọt khí Cắt 3 miếng băng dính
5	Đặt NB ở tư thế thuận tiện. Bộc lộ vùng truyền, lót gối dưới vùng truyền	Thuận tiện khi đâm kim vào tĩnh mạch. Hạn chế lây nhiễm	Chọn tĩnh mạch nổi rõ, không xơ cứng, ít di động. NB nằm

STT			Các bước thực hiện
6	Buộc dây garo, sát khuẩn vị trí tiêm dọc theo tĩnh mạch. Chuẩn bị bông cồn. Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh	Để tĩnh mạch nổi rõ hơn. Hạn chế nhiễm trùng	Dây garo đặt tại vị trí đâm kim khoảng 5 cm, dán hoặc thắt sao cho dễ mở. Sát khuẩn từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài rộng khoảng 5 cm bằng cồn 70% , sát khuẩn đến khi sạch. Thân kim vào trong lòng tĩnh mạch ít nhất 0,5 cm
7	Đâm kim vào tĩnh mạch. Khi thấy máu vào đốc kim, mở dây garo, mở khóa cho dịch chảy	Đảm bảo đúng kỹ thuật tiêm truyền dịch. Tránh tắc kim	Căng da ngược chiều với chiều đâm kim, mũi vát hướng lên trên , có máu vào đốc kim. Thân kim vào trong tĩnh mạch ít nhất 0,5 cm. Mở garo nhẹ nhàng không làm lệch kim ra ngoài tĩnh mạch. Không phồng khi bơm thuốc
8	Đặt gạc che thân kim. Cố định kim và dây truyền. Cố định vùng truyền	Hạn chế nhiễm khuẩn. Lưu kim được an toàn	Gạc che kín thân kim. Cố định đường băng dính đảm bảo chắc đẹp
9	Điều chỉnh tốc độ theo y lệnh. Quan sát NB. Giúp NB về tư thế thoải mái. Hướng dẫn những điều cần thiết	Đảm bảo đúng y lệnh. Phát hiện và xử trí kịp thời khi có tai biến xảy ra	Tốc độ chính xác. Quan sát sắc mặt NB. Dặn NB nếu có: đau hoặc nóng ở vị trí truyền, kích thích vật vã, đỏ mặt, đau thắt lưng, buồn nôn, nôn, sốt, rét run, khó thở phải báo ngay với nhân viên y tế
10	Thu dọn dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ	Tiện việc xử lý dụng cụ, chịu trách nhiệm chuyên môn, pháp lý	Dụng cụ phải bỏ vào nơi đúng quy định, rửa tay thường quy, ghi phiếu truyền dịch

V. AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

TAI BIẾN – TRIỆU TRỨNG	PHÒNG NGỪA- XỬ TRÍ
Đâm nhầm vào động mạch.	Rút ngay kim, băng ép tại điểm đâm kim, theo

TAI BIẾN – TRIỆU TRỨNG	PHÒNG NGỪA- XỬ TRÍ
Thoát mạch: do chệch kim, vỡ tĩnh mạch	Dừng tiêm/truyền, báo bác sĩ; không bơm rửa. Khi nghi thuốc gây tổn thương mô thoát mạch, giữ catheter để xử trí theo phác đồ thuốc trước quyết định rút; không chườm nóng hoặc chích rạch thường quy.
Tụ máu: Do chảy máu vào tổ chức xung quanh hoặc kim xuyên qua mạch	Rút kim truyền, Băng ép quanh nơi tụ máu bằng gạc lạnh
Tuột Catheter: Do cố định không chắc hoặc do NB tự rút truyền	Rút kim truyền
Viêm tĩnh mạch: Do cục máu đông ở đầu kim Catheter; lưu kim Catheter quá lâu; dịch truyền có độ pH quá cao hoặc quá thấp hoặc dịch ưu trương	Rút kim truyền, chườm ấm, báo bác sĩ, ghi chép tình trạng và những xử ttrí
Nhiễm khuẩn tại	Rút kim truyền, chuyển vị trí truyền sang chi khác, báo bác sĩ, theo dõi chăm sóc vị trí nhiễm khuẩn.
Dị ứng thuốc	Ngừng truyền, phối hợp với bác sĩ xử trí sốc phản vệ theo phác đồ nếu có.
Quá tải tuần hoàn: do tốc độ truyền quá nhanh	Ngừng truyền, báo bác sĩ, đánh giá hô hấp và tuần hoàn; hỗ trợ oxy/tư thế theo tình trạng, xử trí theo chỉ định và theo dõi.

LƯU Ý:

- Sử dụng gạc vô khuẩn, hay băng vô khuẩn, để che vị trí đặt catheter.

- Thay băng khi ẩm, bẩn, bong hoặc không bảo đảm; lịch thay định kỳ theo loại băng, catheter và quy định bệnh viện, không áp dụng một lịch chung cho mọi loại.

- Đánh giá nhu cầu và vị trí mỗi lần sử dụng; rút khi không còn chỉ định hoặc có viêm, nhiễm khuẩn, rối loạn chức năng. Thời điểm thay thường quy theo phác đồ, nhóm tuổi và thiết bị đã được duyệt.

- Nếu không thể thay đổi vị trí đặt kim truyền thì phải báo bác sĩ để có hướng xử trí phù hợp.

- Nên rút ngay kim catheter nếu không cần sử dụng

BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRUYỀN DỊCH

STT	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH	CÓ	KHÔNG
	Chuẩn bị người bệnh		
1	Xem y lệnh, thực hiện 5 đúng trước khi tiêm thuốc cho người bệnh		
2	Giải thích để người bệnh yên tâm, dặn người bệnh những điều cần thiết		
3	Nhận định người bệnh		
	Chuẩn bị người điều dưỡng		
4	Điều dưỡng có đủ mũ, áo, khẩu trang, rửa tay thường quy Chuẩn bị và thuốc		
5	Tầng trên: đặt mân lên ngăn trên cùng của xe để dụng cụ, sắp xếp các dụng cụ vào mân (bình kìm, có một kìm kocher, hộp gòn cồn 70% , hộp gòn cồn iod, kéo, băng dính. Hộp chống sốc, dịch truyền theo chỉ định, dây truyền, găng tay)		
6	Tầng giữa: huyết áp, ống nghe, đồng hồ bấm giây, dây garo, gối kê tay, hồ sơ bệnh án, phiếu theo dõi truyền dịch.		
7	Tầng dưới: thùng, hộp đựng rác thải Kỹ thuật tiến hành:		
8	Kiểm tra dịch truyền theo y lệnh, bật và sát khuẩn nút chai		
9	Xé túi đựng dây truyền, khóa dây truyền lại, cắm dây truyền vào chai dịch		
10	Treo chai dịch lên cọc truyền, đuổi khí trong dây truyền khóa lại		
11	Điều dưỡng mang găng		
12	Giúp người bệnh ở tư thế thuận lợi, bộc lộ vùng truyền, xác định vị trí truyền		
13	Đặt gối dưới vùng truyền, đặt dây garo trên vị trí truyền		
14	Thắt dây garo, sát khuẩn vị trí truyền		
15	Đâm kim vào tĩnh mạch, khi thấy máu vào đốc kim, tháo dây garo.		
16	Mở khóa cho dịch chảy, quan sát sắc mặt người bệnh		
17	Cố định đốc kim, đặt gạc phủ vùng truyền		
18	Điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt theo chỉ định		

STT	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH	CÓ	KHÔNG
19	Bỏ gối kê tay, dây garo ra khỏi chi người bệnh giúp người bệnh nằm thoải mái		
20	Dặn người bệnh những điều cần thiết trước khi rời khỏi giường		
	Thu dọn dụng cụ		
21	Thu dọn dụng cụ		
22	Tháo găng tay		
23	Ghi phiếu tiêm truyền, phiếu công khai thuốc, phiếu chăm sóc		

PHỤ LỤC: ĐH.QT.15.ĐD: 09

QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẤY MÁU TĨNH MẠCH XÉT NGHIỆM

I. MỤC ĐÍCH

- Lấy máu xét nghiệm để phục vụ cho công việc chẩn đoán và điều trị có hiệu quả hơn.

- Theo dõi diễn tiến của NB.

II. CHỈ ĐỊNH

- Có chỉ định xét nghiệm cụ thể của người có thẩm quyền.

- Chuẩn bị trước phẫu thuật/sinh theo xét nghiệm được chỉ định; không lấy máu mặc định cho mọi người bệnh.

- NB đang nằm viện để theo dõi kết quả điều trị.

- Khám sức khỏe định kỳ.

III. NHẬN ĐỊNH NGƯỜI BỆNH

- NB có ăn gì trước khi lấy máu hay không

- Hệ thống tĩnh mạch ngoại biên - Tình trạng bệnh lý hiện tại hay các thay đổi bất thường về triệu chứng bệnh

IV. DỤNG CỤ

1. Khay vô khuẩn:

- Ống tiêm (tùy theo lượng máu xét nghiệm)

- Kim số 21

2. Những dụng cụ khác:

- Bông cồn hoặc cồn iod

- Kềm sát trùng da.

- Chai hoặc ống nghiệm: có chất kháng đông hay không tùy loại xét nghiệm

- Dây garo - Túi đựng khác thải y tế

3. Dọn dẹp dụng cụ:

- Xử lý các dụng cụ theo quy trình tiệt khuẩn và khử khuẩn

4. Ghi hồ sơ:

- Ngày giờ lấy mẫu thử.

- Số lượng máu - Loại thí nghiệm.

- Phản ứng của NB nếu có.

- Tên điều dưỡng thực hiện.

5. Những điểm cần lưu ý:

- Nhịn ăn chỉ khi xét nghiệm yêu cầu; xác nhận hướng dẫn phòng xét nghiệm và tình trạng người bệnh.

- Áp dụng kỹ thuật vô trùng để lấy máu

- Trường hợp cấy máu nên lấy trước khi sử dụng kháng sinh

- Không nên lấy máu ở những tĩnh mạch đang truyền dịch

- Lấy đủ số lượng và tính chất máu cần thiết để làm xét nghiệm

V. AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

- Tránh và hạn chế lấy đi lấy lại nhiều lần

- Chuyển mẫu bằng hệ thống/thiết bị chuyển máu an toàn phù hợp; không tháo kim bằng tay để bơm vào ống. Đủ thể tích theo loại ống và xét nghiệm, không ép bơm gây tan máu.

- Lấy đủ số lượng cần xét nghiệm, hạn chế tốn thời gian và gây đau cho NB

- Đảm bảo quy tắc vô trùng khi lấy máu, hạn chế lây bệnh từ NB qua nhân viên y tế

- Đảo nhẹ ống có chất chống đông theo hướng dẫn loại ống; không lắc mạnh. Gắn nhãn ngay tại người bệnh với hai thông tin nhận diện, giờ lấy và người lấy; đối chiếu trước gửi.

VI. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

STT			Các bước thực hiện
Ý nghĩa quy trình Tiêu chuẩn đạt được 1	Báo và giải thích NB, hỏi NB đã ăn gì chưa (nếu cần)	Tiến hành được an toàn và thuận lợi	NB an tâm hợp tác
2	Lộ vùng cần lấy máu (chọn tĩnh mạch rõ và dễ lấy)	Tránh các tai biến tiêm sai vị trí	Chọn tĩnh mạch to rõ ít di chuyển
3	3 Mang găng tay sạch	Bảo vệ nhân viên y tế tránh sự lây nhiễm bệnh từ NB	Mang găng tay đúng cách, cỡ găng phù hợp, để thao tác được gọn gàng

STT			Các bước thực hiện
4	Buộc garo trên vị trí tiêm Giúp tĩnh mạch nổi rõ hơn Buộc garo cách vị trí tiêm từ 10-15 cm 5	Giúp tĩnh mạch nổi rõ hơn	Buộc garo cách vị trí tiêm từ 10-15 cm
5	5 Sát khuẩn rộng vùng da tiêm lấy máu	Hạn chế sự nhiễm khuẩn từ vùng da xung quanh. Giữ an toàn nơi vị trí đâm kim	Sát khuẩn rộng từ trong ra ngoài 5 cm (hoặc sát khuẩn theo đường tĩnh mạch từ dưới lên và ra 2 bên với gạc tẩm cồn 70% hoặc cồn iod)
6	Sát khuẩn tay	Giảm sự lây nhiễm chéo	Sát khuẩn lại đầu ngón tay
7	7 Đâm kim qua da góc 30–40° , hạ góc độ kim xuống luồn kim vào tĩnh mạch	Tiêm vào tĩnh mạch	Tiêm đúng vị trí
8	8 Kéo lui nòng, có máu	Xác định đúng vị trí kim nằm trong tĩnh mạch	Rút nòng nếu thấy máu chảy ra thì chắc chắn kim đã nằm trong lòng tĩnh mạch
9	Rút máu đủ số lượng cần để xét nghiệm	Tùy từng loại xét nghiệm, mà số lượng máu yêu cầu khác nhau	Rút từ từ máu vào ống tim, đủ số lượng để xét nghiệm
10	Tháo garo, rút kim nhẹ nhàng; ép gạc sạch tại vị trí lấy máu	Cầm máu và an toàn	Duy trì ép tới khi cầm máu; kiểm tra trước cho người bệnh rời vị trí.
11	Chuyển máu vào ống bằng hệ thống/thiết bị chuyển an toàn	Tránh phơi nhiễm và tan máu	Không tháo kim bằng tay; đủ thể tích đúng loại ống.
12	Đảo ống theo hướng dẫn loại ống; gắn nhãn tại người bệnh	Mẫu đạt yêu cầu	Không lắc mạnh; hai thông tin định danh, giờ lấy, người lấy.
13	Hủy bơm tiêm và kim	Tránh nguy cơ lây nhiễm cho vật sắc nhọn	Bỏ hẳn bơm tiêm và kim vào thùng nhựa cứng
14	Tháo găng tay, giúp NB tiện nghi	Giao tiếp với NB	Giúp NB tiện nghi
15	Ghi phiếu theo dõi của điều dưỡng, gởi máu đến phòng xét nghiệm ngay	Theo dõi và quản lý NB	NB Ghi lại những công việc đã làm

BẢNG KIỂM QUY TRÌNH LẤY

MÁU TĨNH MẠCH XN

STT	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH	CÓ	KHÔNG
1	Báo và giải thích NB, hỏi NB đã ăn gì chưa (nếu cần		
2	2 Đặt NB ở tư thế thuận tiện		
3	3 Lộ vùng chuẩn bị lấy máu		
4	4 Chọn vùng tĩnh mạch		
5	5 Mang găng tay sạch		
6	6 Buộc garo cách vị trí tiêm từ 10-15 cm		
7	7 Sát khuẩn rộng từ trong ra ngoài 5 cm		
8	8 Căng da, để mũi vát lên trên		
9	9 Đâm kim qua da góc 30–40° , hạ góc độ kim xuống luồn kim vào tĩnh mạch		
10	10 Kéo lui nòng, có máu		
11	11 Rút máu từ từ vào ống tiêm cho đủ số lượng yêu cầu		
12	12 Tháo garo		
13	13 Rút kim ra, ấn nhẹ bông cồn vào nơi tiêm		
14	Chuyển máu bằng thiết bị phù hợp; không tháo kim bằng tay		
15	Đảo nhẹ ống theo hướng dẫn; gắn nhãn ngay tại người bệnh		
16	16 Hủy bơm tiêm và kim		
17	17 Tháo găng tay và giúp NB tiện nghi		
18	18 Thu dọn dụng cụ, rửa tay		
19	19 Ghi hồ sơ		
20	20 Gửi ống nghiệm lên phòng xét nghiệm		

PHỤ LỤC: ĐH.QT.15.ĐD: 10

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRUYỀN MÁU

I. MỤC ĐÍCH

- Bồi hoàn số lượng máu đã mất cho cơ thể NB.

- Bổ sung các yếu tố đông máu.

II. CHỈ ĐỊNH

- Xuất huyết nặng: do tai nạn, phẫu thuật, bệnh lý.

- Thiếu máu nặng: sốt rét, nhiễm ký sinh trùng.

- Các bệnh khác chỉ truyền khi bác sĩ đánh giá có chỉ định loại chế phẩm cụ thể; nhiễm khuẩn/ngộ độc đơn thuần không là chỉ định chung.

- Các bệnh về máu: ung thư máu, thiếu men G6PD.

- Chỉ định truyền và thể tích theo tình trạng, xét nghiệm, loại chế phẩm và phác đồ; không coi mọi bỏng là chỉ định truyền máu.

III. NHẬN ĐỊNH NGƯỜI BỆNH

- Tình trạng tri giác: lơ mơ, hôn mê, co giật, động kinh.

- Tình trạng dấu sinh hiệu, đặc biệt là huyết áp và thân nhiệt.

- Tĩnh mạch: to mềm mại hay nhỏ, xơ cứng.

- Tình trạng bệnh lý đi kèm: đa chấn thương, rối loạn chức năng đông máu.

IV. CHUẨN BỊ NGƯỜI BỆNH

- Đối chiếu và giải thích cho NB.

- Tư thế thích hợp.

- Kiểm tra xem NB có tiền sử dị ứng hay phản ứng với máu không.

V. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

- Túi máu/chế phẩm đúng loại, thể tích và số đơn vị theo y lệnh; một đơn vị không mặc định bằng 500 mL và không áp dụng giới hạn một đơn vị chung cho mọi người bệnh.

- Đây là một khâu quan trọng nhất, nên người điều dưỡng phải kiểm tra đối chiếu cẩn thận - Kiểm tra nhãn hiệu chai máu:

+ Có nhãn không (nếu không có không nhận).

+ Nhãn, mã đơn vị chế phẩm, loại, nhóm máu, thể tích, hạn dùng và các thông tin bắt buộc theo quy trình ngân hàng máu; đối chiếu hồ sơ cấp phát, không lấy tên người hiến làm thông tin xác nhận duy nhất.

- Kiểm tra chất lượng:

+ Nút chai có nguyên vẹn, có rạn nứt không.

+ Kiểm tra túi, màu sắc và dấu hiệu bất thường theo loại chế phẩm; không yêu cầu mọi chế phẩm phân thành ba lớp.

+ Kiểm tra thời điểm nhận, điều kiện bảo quản/vận chuyển và giới hạn sử dụng theo quy trình; không cố ý để túi ngoài tủ lạnh 30 phút để làm ấm.

+ Túi máu lĩnh có phù hợp với phiếu lĩnh máu không.

- Xác nhận xét nghiệm hòa hợp trước cấp phát và kiểm tra tại giường theo quy trình truyền máu; thao tác tại giường không thay thế xét nghiệm hòa hợp của phòng xét nghiệm.

- Một bộ dây truyền máu: có 2 loại, một loại dây thẳng và một loại dây chữ Y vì có thể phải truyền dung dịch mặn nếu có những phản ứng do truyền máu, dây truyền có một cái lọc ở trong bầu nhỏ giọt, khoá dây truyền phải ở dưới bầu nhỏ giọt.

- Catheter và dây truyền có lọc tương thích chế phẩm, cỡ phù hợp người bệnh và tốc độ theo chỉ định.

- Chai nước muối sinh lý NaCl 0,9% (Một vài cơ sở yêu cầu truyền nước muối 0,9% trước và sau khi truyền máu).

- Một cọc truyền tĩnh mạch.

- Bộ tứ (nẹp gỗ, gối kê tay, tấm nylon nhỏ, dây cao su).

- Khay men vô khuẩn.

- Khay quả đậu.

- Kẹp Kocher.

- Huyết áp kế, ống nghe, nhiệt kế, đồng hồ đếm mạch, nhịp thở.

- Hộp thuốc cấp cứu.

- Thuốc theo y lệnh nếu có.

- Dung dịch sát khuẩn, bát kền, kéo, băng dính.

- Dụng cụ làm phản ứng chéo, huyết thanh mẫu.

- Bơm tiêm vô khuẩn 5 mL - 10 mL.

- Gạc miếng đã hấp.

- Phiếu truyền máu.

VI. QUY TRÌNH TRUYỀN MÁU

Các bước thực hiện **Ý nghĩa quy trình** **Tiêu chuẩn đạt được**
Kiểm tra y lệnh
Thông báo, giải thích và hướng dẫn NB những điều cần thiết. Đo DHST, xác định vị trí truyền máu

Đảm bảo đúng nguyên tắc khi truyền máu Giúp NB hợp tác khi truyền máuĐảm bảo 5 đúng: Tạo được thiện chí giữa điều dưỡng và NB2

Vệ sinh tay, chuẩn bị dụng cụ và nhận đúng chế phẩm

An toàn truyền máu

Bảo quản/vận chuyển và sử dụng theo loại chế phẩm; không để ngoài 30 phút để làm ấm.

3 Mang dụng cụ đến bên giường NB để nơi thuận tiệnThuận lợi trong các tiến hành thao tácDụng cụ đặt nơi thuận tiện với vị trí truyềnKiểm tra túi máu Kiểm tra NBTránh nhầm lẫnKiểm tra đầy đủ: tên người cho, hạn dụng, số hiệu, chất lượng, số lượng, nhóm máu

Kiểm tra đúng: tên người nhận, nhóm máu, số lượng5

Kiểm tra hai thông tin NB, nhãn túi, y lệnh và hồ sơ hòa hợp tại giường

Ngăn nhầm chế phẩm

Theo quy trình truyền máu đã duyệt; kiểm tra tại giường không thay xét nghiệm hòa hợp.

6 Lắc nhẹ túi máu, cắm dây truyền vào túi máu, treo lên cọc truyền, đuổi khí, khóa lại

Trộn lẫn các thành phần của máu. Tránh không khí vào mạch máuKhông làm vỡ hồng cầu. Đuổi khí đến đầu dây truyền khi không còn không khí trong dây7 Cắt băng dính. Chọn tĩnh mạch, lót gối dưới vùng truyền Thuận tiện khi tiến hành NB ở tư thế nằm tĩnh mạch nổi rõ, to, không bị xơ cứng, ít di động, thẳng và không nằm ở vị trí cử động

Thuận tiện khi tiến hànhNB ở tư thế nằm tĩnh mạch nổi rõ, to, 8không bị xơ cứng, ít di động, thẳng và không nằm ở vị trí cử độngBuộc dây garo, sát khuẩn vị trí tiêm dọc theo tĩnh mạch. Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh

Để tĩnh mạch nổi rõ hơn. Hạn chế nhiễm trùng

Dây garo dán hoặc thắt sao cho dễ mở. Sát khuẩn từ dưới lên, từ trong ra ngoài rộng khoảng 5 cm đến khi sạch

Đâm kim vào tĩnh mạch Khi thấy máu vào đốc kim, mở dây garo, mở khóa cho máu chảy Đảm bảo đúng kỹ thuật truyền máu Tránh tắc kim Căng da ngược với chiều đâm

Đảm bảo đúng kỹ thuật truyền máu Tránh tắc kim

Căng da ngược với chiều đâm kim, mũi vát hướng lên, có máu vào trong đốc kim Thân kim vào trong tĩnh mạch còn lại khoảng 0,5 cm. Mở garo nhẹ nhàng, không làm lệch kim, không phồng khi máu chảy

Đặt gạc che thân kim. Cố định kim và dây truyền.

Lưu kim được an toàn. Hạn chế nhiễm khuẩn

Gạc che kín thân kim. Cố định đường băng dính đảm bảo chắn đẹp

Theo dõi NB trong vòng 15 phút

Đảm bảo nguyên tắc truyền máu. Phát hiện sớm tai biến

Theo dõi DHST Tốc độ chính xác theo y lệnh

Giúp NB về tư thế thoải mái, hướng dẫn điều cần thiết

Đề phòng tai biến, phát hiện và xử trí kịp thời khi có tai biến xảy ra

Dặn NB nếu có:đau hoặc nóng ở vị trí truyền, kích thích vật vã, đỏ mặt, đau thắt lưng, buồn nôn, nôn, sốt, rét run, khó thở phải báo ngay với nhân viên y tế

Thu dọn dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ

Tiện việc xử lý dụng cụ, chịu trách nhiệm chuyên môn

rửa tay thường quy, ghi đúng vào phiếu truyền máu, phiếu chăm sóc

VII. AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

TAI BIÊN XẢY RA	XỬ TRÍ- PHÒNG CHỐNG
Nhóm máu: NB đau nhức khắp người, đau lưng dữ dội, vật vã, khó chịu tức ở ngực, ớn lạnh: Sốt cao, Có thể trụy tim mạch	Khi nghi phản ứng truyền máu, ngừng truyền ngay, gọi bác sĩ; đánh giá người bệnh, duy trì đường truyền bằng bộ dây mới/dịch phù hợp theo phác đồ. Báo đơn vị cấp phát, giữ túi và dây, lấy mẫu theo chỉ định; ghi hồ sơ và theo dõi.
Phản ứng sốt	Khi nghi phản ứng truyền máu, ngừng truyền ngay, gọi bác sĩ; đánh giá người bệnh, duy trì đường truyền bằng bộ dây mới/dịch phù hợp theo phác đồ. Báo đơn vị cấp phát, giữ túi và dây, lấy mẫu theo chỉ định; ghi hồ sơ và theo dõi.

TAI BIÊN XẢY RA	XỬ TRÍ- PHÒNG CHỐNG
Phản ứng dị ứng: Ngứa mẫn đỏ, hen phế quản, phù phổi cấp và trụy tim mạch(ít gặp)	Khi nghi phản ứng truyền máu, ngừng truyền ngay, gọi bác sĩ; đánh giá người bệnh, duy trì đường truyền bằng bộ dây mới/dịch phù hợp theo phác đồ. Báo đơn vị cấp phát, giữ túi và dây, lấy mẫu theo chỉ định; ghi hồ sơ và theo dõi.
Viêm tắc tĩnh mạch: Triệu chứng: sưng đỏ, nóng, đau tại chỗ và dọc theo đường tĩnh mạch. Xử trí: điều trị viêm tắc tĩnh mạch Xử trí: điều trị viêm tắc tĩnh mạch	Khi nghi phản ứng truyền máu, ngừng truyền ngay, gọi bác sĩ; đánh giá người bệnh, duy trì đường truyền bằng bộ dây mới/dịch phù hợp theo phác đồ. Báo đơn vị cấp phát, giữ túi và dây, lấy mẫu theo chỉ định; ghi hồ sơ và theo dõi.

BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRUYỀN MÁU

STT	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH	CÓ	KHÔNG
	Chuẩn bị người bệnh		
1	Kiểm tra hồ sơ người bệnh		
2	Thông báo về kỹ thuật sắp làm		
3	Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn		
4	Hỏi người bệnh có tiền sử dị ứng không?		
5	Kiểm tra lại các xét nghiệm của người bệnh		
	Chuẩn bị người điều dưỡng		
6	Mang đồng phục y tế, đeo khẩu trang		
7	Rửa tay thường quy Chuẩn bị dụng cụ		
8	Hai mâm, bình kìm -một kìm kocher, cồn iot, cồn 70% , hai hộp đựng gòn		
9	Hộp chống sốc, huyết áp, ống nghe, đồng hồ bấm giây, găng tay		
10	Kéo, băng dính, cọc truyền, túi máu, phiếu theo dõi truyền máu, dây truyền máu.		
11	Hộp vô khuẩn: gạc tam giác, gạc phủ vùng truyền		
12	Gối kê tay, dây garo, hai lam kính, kim chích máu		

STT	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH	CÓ	KHÔNG
13	Dụng cụ và phương tiện kiểm tra truyền máu theo quy trình đã duyệt; bảo quản thuốc thử theo hướng dẫn nhà sản xuất		
14	Túi đựng đồ bẩn Kỹ thuật tiến hành		
15	Điều dưỡng mang găng tay		
16	Thực hiện kiểm tra nhận diện, túi máu và hồ sơ hòa hợp tại giường theo quy trình; xác nhận đầy đủ trước truyền		
17	Kiểm tra lại túi máu, lắc nhẹ treo túi máu lên cọc truyền		
18	Xé túi đựng dây truyền, khóa dây truyền lại, cắm dây truyền vào túi máu		
19	Tiến hàng đuổi khí trong dây truyền		
20	Để người bệnh ở tư thế thuận lợi, bộc lộ vùng truyền, đặt gối kê tay, đặt và thắt dây garo		
21	Sát khuẩn vị trí truyền bằng cồn iot, cồn 70%		
22	Đặt gạc tam giác, đâm kim vào tĩnh mạch, tháo dây garo, mở khóa dây truyền		
23	Cố định đốc kim, phủ gạc vô khuẩn lên vùng truyền, bỏ gối, dây garo.		
24	Thu dọn dụng cụ Sắp xếp dụng cụ gọn gàng Phân loại và thu gom rác thải đúng quy định		
25	Tháo găng tay		
26	Ghi vào hồ sơ theo dõi - Thời gian bắt đầu truyền - Số lượng máu đã truyền - Đáp ứng của cơ thể với dịch truyền - Thời gian kết thúc		

RÀ SOÁT TRƯỚC BAN HÀNH

Bệnh viện xác nhận mã, phiên bản, quyết định và người ký; đơn vị quản lý tài liệu; danh mục thuốc, vật tư và thiết bị đang dùng.

Phê duyệt quy trình thuốc/dị nguyên cụ thể cho thử trong da và lẩy da, gồm chỉ định, chống chỉ định, nồng độ, chứng, thể tích, đọc kết quả và năng lực người thực hiện. Không áp dụng bảng này như phác đồ thử chung.

Gắn phác đồ phản vệ đầy đủ tại nơi tiêm và bảo đảm nhân viên được tập huấn; liều/cách pha thực hiện theo văn bản và phác đồ đã phê duyệt.

Hội đồng truyền máu, đơn vị cấp phát và phòng xét nghiệm xác nhận quy trình hòa hợp, kiểm tra tại giường, bảo quản, thời gian, theo dõi và xử trí phản ứng theo từng chế phẩm.

Khoa KSNK và Khoa Dược xác nhận sát khuẩn, thay catheter/băng, quản lý lọ đa liều, ghi nhãn thuốc, phân loại chất thải và quy trình xử lý phơi nhiễm.

Bổ sung lịch sử sửa đổi chính thức và hướng dẫn chấm bảng kiểm. Các điều chỉnh trong bản này cần thẩm định chuyên môn trước áp dụng.